THAMYRES TOSARELLI

FACETA DIRETA EM RESINA COMPOSTA

Trabalho de Conclusão de Curso

Primeira parte: Introdução, Objetivos e Revisão de Literatura

2026

1 INTRODUÇÃO

A aparência do sorriso tem um peso cada vez maior na forma como as pessoas se veem e são vistas. Soares e Borges (2023) observaram que a estética dental passou a ser procurada não só por saúde, mas também por autoestima, aceitação social e bem-estar, e que essa procura cresceu bastante com a influência das redes sociais. Rocha et al. (2021) explicaram que dentes com alteração de cor, forma ou posição costumam ser percebidos como fora do padrão divulgado pela mídia, o que pode gerar insegurança, timidez e até isolamento, levando o paciente ao consultório em busca de uma solução. Bento et al. (2021) mostraram que esse impacto não é apenas subjetivo: no caso relatado pelos autores, a qualidade de vida do paciente, medida pelo questionário OHIP-14, melhorou de forma clara após o tratamento estético.

Silva, I. et al. (2021) apontaram que as queixas mais frequentes dos pacientes envolvem a cor dos dentes, o contorno inadequado e a presença de diastemas, e que, para resolvê-las, o cirurgião-dentista pode indicar clareamento dental, tratamento ortodôntico, laminados cerâmicos ou facetas diretas em resina composta, muitas vezes combinando essas opções. Lima et al. (2020) destacaram que, no caso dos diastemas, as restaurações diretas oferecem tempo reduzido de trabalho, baixo custo e resultado imediato.

Alves, Peres e Lima (2022) e Brito, Ferreira e Yamashita (2022) descreveram as facetas como procedimentos que recobrem a face vestibular dos dentes para melhorar sua estética e função, podendo ser confeccionadas de forma direta, com resina composta aplicada no próprio consultório, ou de forma indireta, com peças de cerâmica ou de resina produzidas em laboratório. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) e Soares e Borges (2023) destacaram as vantagens da técnica direta: exige pouco ou nenhum desgaste do dente, pode ser concluída em uma única sessão, dispensa etapas laboratoriais, tem custo menor e permite reparos dentro da boca.

Boa parte dessa popularidade se deve à evolução das próprias resinas compostas. Lanzaretti et al. (2025) e Dominguez et al. (2024) relataram que os materiais nano-híbridos e nanoparticulados melhoraram o polimento, a resistência e a estabilidade de cor, permitindo restaurações cada vez mais próximas do dente natural. Nalbandian e Millar (2009), em um estudo com pacientes tratados com facetas de resina ou de porcelana, não encontraram diferença na melhora estética

percebida pelos próprios pacientes entre os dois materiais, o que reforça a resina como uma alternativa válida e mais conservadora.

Por outro lado, a técnica não está livre de problemas. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) lembraram que as facetas diretas são mais suscetíveis ao desgaste, ao manchamento e à fratura, e Cruz et al. (2023) apontaram que grande parte das falhas está ligada à execução do profissional e a fatores do próprio paciente, como hábitos parafuncionais e higiene deficiente. Reis et al. (2018) mostraram que o sucesso também depende de um bom planejamento, com recursos como o enceramento diagnóstico e o mock-up, e Santos et al. (2022) alertaram para o respeito aos tecidos periodontais, já que facetas mal adaptadas podem causar inflamação gengival.

Mesmo sendo um tratamento muito difundido, a literatura ainda não chegou a um consenso sobre a durabilidade das facetas diretas quando comparadas às indiretas. Galvão et al. (2025), em uma revisão sistemática recente, apontaram maior sobrevida para as facetas diretas, enquanto Teixeira et al. (2022) observaram vantagem das facetas indiretas de porcelana. Diante disso, torna-se importante reunir o que os estudos mostram sobre as indicações, a técnica, o planejamento e a longevidade das facetas diretas em resina composta, para que o cirurgião-dentista possa indicá-las com segurança e executá-las com previsibilidade.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Analisar, por meio de uma revisão de literatura, as facetas diretas em resina composta em dentes anteriores, reunindo as evidências sobre suas indicações, técnica de confecção e longevidade clínica, a fim de orientar a sua indicação e execução na prática clínica.

2.2 Objetivos específicos

a) contextualizar a importância da estética do sorriso e a evolução dos materiais restauradores estéticos;
b) descrever a composição, a classificação e as propriedades das resinas compostas utilizadas nas facetas diretas;
c) explicar os princípios de adesão e os protocolos dos sistemas adesivos empregados na técnica;
d) identificar as indicações, as contraindicações, as vantagens e as desvantagens das facetas diretas;
e) comparar as facetas diretas em resina composta com as facetas indiretas;
f) descrever as etapas de planejamento e de confecção das facetas diretas, do exame clínico ao acabamento e polimento;
g) discutir a relação entre as facetas diretas e a saúde periodontal;
h) analisar a longevidade, as principais causas de falha e os cuidados de manutenção das facetas diretas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 A estética do sorriso

O sorriso é considerado um dos recursos mais importantes da expressão facial. Silva, I. et al. (2021) relataram que, a partir da década de 1990, houve um aumento na valorização da estética dental, associada a dentes brancos, alinhados e bem contornados, e que um sorriso agradável transmite harmonia, admiração e simpatia, enquanto a sua ausência pode ser interpretada de forma negativa nas interações sociais. Os autores citam ainda estudos sobre microexpressões faciais que mostram que um sorriso aberto, com os dentes à mostra, costuma ser interpretado como sinal de confiança, e que pessoas com sorriso agradável são vistas como mais confiantes e sociáveis, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Segundo esses autores, a harmonia do sorriso depende da simetria dos dentes entre si e com a linha média da face, em equilíbrio com a gengiva, os lábios e o rosto, de modo que assimetrias de tamanho, espaçamento ou cor prejudicam a forma como o paciente percebe a própria imagem. Vookanti et al. (2026) complementaram essa ideia ao citar como determinantes estéticos a forma, a simetria, a proporção, o alinhamento, a textura, a cor e a translucidez dos dentes, aliados a uma função e uma fonética adequadas.

Soares e Borges (2023) observaram que a odontologia estética cresceu muito com a influência das redes sociais e que a aparência passou a ser um determinante da autoestima. Rocha et al. (2021) acrescentaram que a falta de harmonia no sorriso pode gerar ansiedade, insegurança, timidez e até isolamento social, e que muitos pacientes buscam tratamentos que influenciem a sua autoimagem, e não apenas a função. Lanzaretti et al. (2025) também destacaram que a estética do sorriso influencia as relações sociais, a autoestima e a forma como cada pessoa se vê. Santos et al. (2022) lembraram, porém, que o conceito de estética é subjetivo, pois depende de fatores sociais, culturais e psicológicos de cada indivíduo.

Algumas alterações de forma, mesmo sem comprometer a saúde bucal, têm grande impacto estético. Lanzaretti et al. (2025) citaram como exemplo os incisivos laterais conoides, que podem atingir até 2,5% da população e costumam vir acompanhados de diastemas e assimetrias. Bento et al. (2021) mediram o impacto desse tipo de correção aplicando o questionário OHIP-14 antes e depois de uma

reabilitação com facetas diretas, e a pontuação caiu de 24 para 5 pontos, indicando melhora importante na qualidade de vida. Por isso, Dominguez et al. (2024) destacaram que a simetria facial, as proporções dentárias, a linha do sorriso e a exposição gengival devem ser consideradas no planejamento, e Cruz et al. (2023) reforçaram que a análise deve incluir a face e os lábios, e não apenas os dentes.

3.2 Evolução dos materiais restauradores estéticos

Alves, Peres e Lima (2022) relataram que as facetas surgiram na década de 1930, quando Charles Pincus as desenvolveu para realçar o sorriso de atores americanos. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram, porém, que no começo do século XX a maior parte dos procedimentos odontológicos se resumia a extrações, e que só aos poucos surgiram materiais capazes de devolver estética e função. Lanzaretti et al. (2025) relataram que as primeiras restaurações estéticas eram feitas com cimentos de silicato e, no início da década de 1950, passaram a ser feitas com resinas acrílicas de polimetilmetacrilato. Segundo esses autores, nessa época as restaurações posteriores ainda eram feitas quase sempre com amálgama, e os materiais estéticos ficavam reservados aos dentes anteriores, onde a aparência era prioridade.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Lanzaretti et al. (2025) destacaram que, nessa mesma época, Buonocore desenvolveu a técnica do condicionamento ácido do esmalte com ácido fosfórico, que permitiu unir a restauração ao dente e selar suas margens, sendo considerada um marco da odontologia adesiva. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) acrescentaram que, em 1956, Bowen introduziu o Bis-GMA, que melhorou as propriedades das resinas, e que, a partir da década de 1970, as partículas de carga e os aparelhos fotopolimerizadores também evoluíram.

Alves, Peres e Lima (2022) e Cruz et al. (2023) relataram que as resinas compostas estão presentes na clínica há mais de 50 anos e que a melhora contínua da sua composição ampliou suas indicações, inclusive para problemas estéticos. Nalbandian e Millar (2009) lembraram que as primeiras facetas diretas em resina, no fim da década de 1970 e início da de 1980, decepcionaram pela pouca estabilidade de cor, perda do polimento e desgaste, mas que as resinas atuais têm propriedades muito superiores. Silva, I. et al. (2021) consideraram essa evolução especialmente

marcante nos últimos 20 anos, com melhores propriedades mecânicas e ópticas e sistemas adesivos mais eficientes.

Cruz et al. (2023) apontaram como passo importante dessa evolução as resinas nano-híbridas e nanoparticuladas, surgidas em meados dos anos 2000, com resistência semelhante à das micro-híbridas e polimento semelhante ao das microparticuladas. Teixeira et al. (2022) relataram ainda a chegada ao mercado das facetas pré-fabricadas de resina composta, feitas de resina híbrida pré-polimerizada e cimentadas com a mesma resina, formando um conjunto único com o dente. Alves, Peres e Lima (2022) lembraram que a técnica de estratificação com fins estéticos ganhou força justamente com o desenvolvimento da fotopolimerização e de sistemas de resina com diferentes opacidades. Mesmo assim, Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram que as resinas ainda apresentam limitações, como a contração durante a polimerização e o estresse gerado por ela.

3.3 Resinas compostas

3.3.1 Composição e classificação

Soares e Borges (2023) explicaram que as resinas compostas são formadas por uma matriz orgânica, uma parte inorgânica, um sistema iniciador e um agente de união, sendo a matriz composta por monômeros que se transformam em polímeros durante a polimerização. Cruz et al. (2023) destacaram que esses materiais oferecem grande variedade de cores e reproduzem translucidez, opalescência e fluorescência, e explicaram que a classificação das resinas se baseia no tamanho das partículas de carga, na viscosidade e na forma de ativação. Quanto ao tamanho, podem ser macroparticuladas, microparticuladas, micro-híbridas e nanoparticuladas, além das supra-nano, com partículas próximas de 200 nanômetros. Quanto à viscosidade, podem ser de baixa, média ou alta, e quanto à ativação, fotoativadas ou ativadas quimicamente.

Dominguez et al. (2024) relataram que as resinas microparticuladas oferecem acabamento superior e são fáceis de manipular, mas têm menor resistência mecânica, enquanto as nano-híbridas, por combinarem nanopartículas com partículas maiores, mantêm um polimento duradouro e resistem melhor ao desgaste e à fratura. Soares e Borges (2023) explicaram que, nas nanoparticuladas, as partículas chegam a 0,02 µm, o que garante superfície mais lisa, ótimo brilho e boas

propriedades mecânicas, e Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que essas resinas reproduzem bem a fluorescência e a opacidade do dente, com menor contração de polimerização e boa estabilidade de cor.

Para as facetas, Cruz et al. (2023) afirmaram que a resina precisa ter boa lisura, bom escoamento, variedade de cores e estabilidade, características das resinas microparticuladas, nanoparticuladas e nano-híbridas. Segundo os autores, as microparticuladas têm alto polimento, mas resistência limitada em grandes reconstruções, enquanto as micro-híbridas, mais resistentes e com polimento inferior, são recomendadas para alongamentos e para a face palatina. Lima et al. (2020) indicaram a microparticulada como material de eleição para fechar diastemas de até 2 mm, pelo polimento semelhante ao do esmalte e pela translucidez. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que as resinas microparticuladas e nanoparticuladas ficam mais lisas após o polimento que as micro-híbridas, e que as nanoparticuladas se degradam menos na cavidade bucal. Alves, Peres e Lima (2022) lembraram que escolher a resina exige equilibrar requisitos como longevidade, resistência, tenacidade à fratura, dureza superficial, baixo desgaste e baixa degradação, e Teixeira et al. (2022) acrescentaram que, embora a escolha também dependa da preferência do clínico, ele precisa conhecer as propriedades de cada material.

3.3.2 Propriedades

Dominguez et al. (2024) apontaram a contração de polimerização como a principal preocupação no uso das resinas, pois pode causar microinfiltração marginal, sensibilidade pós-operatória e falhas, e lembraram que cada formulação apresenta uma taxa diferente de contração. Os autores destacaram ainda a resistência à abrasão, essencial para manter a estética com o tempo e dependente do tamanho e da distribuição das partículas de carga; o módulo de elasticidade, que, quando próximo ao do dente, reduz as tensões na interface e o risco de fratura; e o coeficiente de expansão térmica, que, quando semelhante ao do dente, diminui o risco de microinfiltração e fraturas causadas por variações de temperatura.

Cruz et al. (2023) explicaram que falhas na fotoativação podem reduzir o grau de conversão da resina, causando alterações de cor, maior desgaste, infiltração marginal, monômero residual e piora das propriedades mecânicas. Por isso, Alves,

Peres e Lima (2022) e Cruz et al. (2023) consideraram fundamental a escolha correta da resina, do sistema adesivo e do aparelho fotopolimerizador.

3.3.3 Desempenho clínico e laboratorial

Irgang et al. (2020) avaliaram retrospectivamente 74 facetas diretas em 28 pacientes, com tempo médio de três anos em boca, variando de seis meses a dez anos, comparando resinas microparticuladas e universais pelos critérios FDI e USPHS. A taxa de sobrevivência foi de 77%, com 17 falhas, e as três perdas completas ocorreram no grupo das universais. As microparticuladas tiveram melhor desempenho em brilho, manchamento, correspondência de cor e adaptação marginal. Bastos et al. (2018) acompanharam por seis meses facetas feitas com uma resina de carga supra-nano esférica em uma paciente com dentes escurecidos e bruxismo, e observaram bom aspecto clínico, sem acúmulo de biofilme nem desgaste.

Fernandes et al. (2022) compararam em laboratório a microdureza das resinas Filtek Z350 XT e Filtek One Bulk Fill, polimerizadas pela técnica imediata ou de pulso tardio, em 40 corpos de prova. A técnica imediata produziu dureza significativamente maior, e a Z350 XT foi mais dura que a bulk fill nas duas técnicas. Os autores lembraram que as técnicas alternativas de polimerização surgiram para diminuir o estresse de contração e o tempo de atendimento, mas concluíram que a técnica convencional ainda alcança maior dureza. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) imergiram cinco resinas de alta translucidez (Filtek Z350 XT Translucent, Forma Trans, Palfique LX5, Beautifil II e Opallis T-Neutral) em uma bebida energética por dez minutos diários, durante 30 dias, e verificaram que todas perderam dureza e ficaram mais rugosas. A Filtek Z350 XT manteve a maior dureza, a Forma Trans foi a mais estável e a Beautifil II foi a mais afetada, e os autores concluíram que materiais com nanoaglomerados e zircônia resistem melhor à degradação ácida.

3.4 Sistemas adesivos

Dominguez et al. (2024) afirmaram que uma ligação estável entre a resina e o dente é fundamental para a longevidade da faceta. Segundo os autores, o condicionamento com ácido fosfórico remove a camada superficial de hidroxiapatita

e cria uma superfície microrretentiva, e o sistema adesivo funciona como uma ponte entre a resina e o dente, selando as margens da restauração. Os mesmos autores citaram a existência de diversas gerações de adesivos e a teoria do monômero bifuncional, proposta por Bowen em 1965, segundo a qual os monômeros penetram na estrutura dental e criam uma ancoragem para a resina.

Alves, Peres e Lima (2022) destacaram que a adesão ao esmalte é simples de obter e é a mais forte da cavidade bucal, o que permite preparos menores, e Teixeira et al. (2022) reforçaram que a adesão ideal ocorre quando o preparo fica totalmente em esmalte. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que dentes com menos de 50% de esmalte remanescente não têm boa indicação para facetas, pois a retenção fica deficiente e aumenta o risco de infiltração e descolamento.

Alves, Peres e Lima (2022) descreveram o protocolo com ácido fosfórico a 37% por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina, lavagem por 20 segundos, secagem, duas aplicações do adesivo e fotoativação por 40 segundos. Soares e Borges (2023) citaram um protocolo com condicionamento por 30 segundos no esmalte, lavagem por 60 segundos e adesivo universal fotoativado por 20 segundos. Silva, I. et al. (2021) chamaram essa etapa de hibridização do substrato e a posicionaram logo após os ajustes do mock-up, e Galvão et al. (2025) observaram que a maioria dos estudos clínicos incluídos em sua revisão utilizou o sistema Clearfil SE Bond, considerado padrão-ouro na adesão ao esmalte e à dentina.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) alertaram que a adesão precisa respeitar as propriedades de cada produto, pois falhas nessa etapa ou na fotopolimerização comprometem a interface adesiva e podem causar pigmentação. Lima et al. (2020) afirmaram que o sucesso das facetas depende de o cirurgião-dentista compreender os princípios dos sistemas adesivos, e Silva, I. et al. (2021) ressaltaram que foi justamente a evolução desses sistemas que tornou possível reabilitar os dentes com preparos mínimos ou sem desgaste, e Cruz et al. (2023) afirmaram que, graças à evolução conjunta das resinas e dos adesivos, vivemos hoje uma era de preservação das estruturas dentais saudáveis.

3.5 Facetas diretas em resina composta

3.5.1 Conceito

Silva, I. et al. (2021), Brito, Ferreira e Yamashita (2022) e Cruz et al. (2023) definiram as facetas como restaurações que recobrem a face vestibular do dente com um material fixado por meio de sistemas adesivos, podendo ser diretas, com resina composta, ou indiretas, com cerâmica ou resina processada fora da boca. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) explicaram que as diretas são aplicadas diretamente no consultório, enquanto as indiretas são produzidas em laboratório e depois cimentadas. Cruz et al. (2023) destacaram que a faceta direta foi criada para preservar ao máximo a estrutura dental, e Soares e Borges (2023) a consideraram um procedimento menos invasivo, que normalmente não exige preparo. Santos et al. (2022) ressalvaram, porém, que ela não é a mais conservadora das restaurações diretas e deve ser indicada com critério.

3.5.2 Indicações

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) listaram como indicações as alterações de cor e forma, os dentes escurecidos ou manchados, a amelogênese imperfeita, as microdontias, as alterações de posição, as perdas de estrutura por desgaste, os dentes girovertidos, as fraturas e os diastemas. Dominguez et al. (2024) acrescentaram as manchas, as lascas e o fechamento de espaços, e Cruz et al. (2023) incluíram o desalinhamento e as sequelas de cárie. Alves, Peres e Lima (2022) observaram que pequenas discrepâncias de alinhamento, que levariam meses para serem corrigidas com ortodontia, podem ser resolvidas com a técnica direta.

Os diastemas estão entre as indicações mais comuns. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram que, no adulto, o diastema dá ao sorriso um aspecto infantil e pode incomodar bastante o paciente, e que a resina consegue preencher esse espaço de forma rápida. Lima et al. (2020) consideraram as restaurações diretas uma opção de destaque nesses casos, e Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que, quando há apenas uma pequena desproporção entre os dentes, as facetas podem substituir a ortodontia, desde que se faça o diagnóstico diferencial, avaliando

idade, crescimento facial, tamanho dos dentes, inserção do freio labial e hábitos deletérios, já que diastemas maiores podem exigir ortodontia, cirurgia ou próteses.

Os relatos de caso mostram essa variedade. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) usaram facetas diretas em três pacientes: um paciente de 37 anos com fratura das bordas incisais, outro com dentes escurecidos e um terceiro com uma restauração antiga deficiente, acompanhando os casos por seis meses. Dias et al. (2020) trataram manchas brancas lisas, brilhantes e bem delimitadas na região cervical dos dentes de uma paciente de 21 anos, diagnosticadas como cárie inativa, Vookanti et al. (2026) mascararam as manchas brancas e acastanhadas da fluorose moderada e Rocha et al. (2021) reanatomizaram incisivos laterais conoides. Em dentes escurecidos, Silva, I. et al. (2021) explicaram que manchas por sais metálicos podem impedir o clareamento, exigindo outras técnicas. Joshi (2025) fez clareamento interno antes das facetas em um dente desvitalizado, enquanto Falcão et al. (2023), em um dente que não podia ser clareado novamente, usaram pigmentos opacificadores. Soares e Borges (2023) explicaram que os opacificadores bloqueiam a passagem da luz e são uma alternativa mais conservadora do que aumentar o desgaste.

3.5.3 Contraindicações

Cruz et al. (2023) contraindicaram as facetas em pacientes com doença periodontal grave, sobremordida acentuada, bruxismo e má higiene bucal. Santos et al. (2022) incluíram ainda dentes sem suporte saudável, com menos de 50% de esmalte, muito vestibularizados, com múltiplas restaurações ou grande giroversão, além de oclusão topo a topo, mordida cruzada e apinhamento. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) observaram que, em pacientes com bruxismo severo, as facetas de resina exigem manutenção frequente para repolimento, e Teixeira et al. (2022) relataram que os descolamentos são mais frequentes quando o paciente com bruxismo não usa a placa miorrelaxante. Dominguez et al. (2024) acrescentaram que morder objetos duros, roer unhas ou usar os dentes como ferramenta também aumentam o risco de danos.

3.5.4 Vantagens e desvantagens

Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) destacaram como vantagens o preparo mínimo ou ausente, o menor custo, a reversibilidade, a dispensa de cimentação, o polimento fácil, a possibilidade de reparo na boca e a boa adaptação marginal. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram a sessão única e a ausência de provisórios, e Cruz et al. (2023) consideraram a técnica mais conservadora, mais barata e mais rápida que as facetas cerâmicas. Dominguez et al. (2024) reforçaram que as facetas de resina podem preservar inclusive a vitalidade pulpar, e Alves, Peres e Lima (2022) ressaltaram a capacidade da resina de reproduzir morfologia, cor, translucidez e opacidade. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram ainda a mínima agressão ao periodonto e o bom custo-benefício, tanto para o paciente quanto para o profissional.

Entre as desvantagens, Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) apontaram a menor resistência ao desgaste e a maior suscetibilidade ao manchamento e às fraturas. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram a perda de brilho e o amarelamento mais rápido, e Silva, I. et al. (2021) relacionaram a instabilidade de cor à composição da resina, que também pode sofrer microinfiltrações. Dominguez et al. (2024) observaram que o manchamento e o desgaste são maiores em pacientes que consomem alimentos pigmentados, fumam ou têm higiene deficiente, Teixeira et al. (2022) relataram descolamento, desgaste e fendas marginais, e Lanzaretti et al. (2025) apontaram a necessidade de manutenção periódica. Alves, Peres e Lima (2022) observaram que a resistência mecânica das facetas diretas pode ser inferior à das restaurações indiretas. Silva, I. et al. (2021) lembraram ainda que a técnica exige habilidade manual e atenção na escolha da cor e no acabamento.

3.5.5 Facetas diretas e indiretas

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que as facetas indiretas são uma alternativa protética para modificar forma, posição e cor dos dentes, e que a fabricação fora da boca permite melhor detalhamento anatômico. Silva, I. et al. (2021) acrescentaram que a técnica indireta é uma boa opção para profissionais com menos habilidade manual, mas tem custo maior, exige mais sessões e depende de cimentação. Os mesmos autores descreveram os laminados cerâmicos, mais finos e com preparo restrito ao esmalte, mas com dificuldade para mascarar dentes

muito escurecidos e contraindicados em pacientes com bruxismo ou doença periodontal grave. Teixeira et al. (2022) lembraram que as cerâmicas também são frágeis, têm baixa resistência à tração e dependem de etapas laboratoriais demoradas.

Lanzaretti et al. (2025) compararam o tempo de cadeira das duas técnicas: os laminados exigem preparo, moldagem, provisório e uma consulta a mais para a cimentação, enquanto as facetas diretas precisam apenas de um enceramento diagnóstico e de uma sessão restauradora, sendo especialmente indicadas para pacientes jovens. Alves, Peres e Lima (2022) apresentaram uma comparação em que a resina se destaca pela preservação do dente e pelo menor custo, e a cerâmica, pela estabilidade de cor. Nalbandian e Millar (2009) compararam a opinião de 96 pacientes, entre 145 consultados, tratados com dez facetas de resina ou dez de porcelana, por meio de escalas visuais que avaliavam cor, forma, tamanho, linha do sorriso e aparência facial antes e depois do tratamento. Não houve diferença na melhora estética percebida, e a conservação do dente, o tempo e os custos de reparo e substituição favoreceram a resina, levando os autores a concluir que, quando bem informados, os pacientes podem preferir a opção mais conservadora. Vaz, Lopes e Toledo Neta (2022) mostraram que os dois materiais também podem ser combinados: em uma paciente de 21 anos com desalinhamento, usaram cerâmica de dissilicato de lítio nos seis dentes anteriores e resina composta Z350 XT nos pré-molares, como alternativa à ortodontia, e concluíram que a associação de diferentes materiais corrigiu o alinhamento e devolveu estética e função.

3.6 Planejamento

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que o planejamento deve considerar não só a estética, mas também a saúde bucal, com uma consulta minuciosa para identificar cáries, doença periodontal ou necessidade de endodontia. Cruz et al. (2023) e Silva, I. et al. (2021) detalharam que o exame deve incluir a avaliação de restaurações prévias, lesões cariosas e periapicais, radiografias e teste de vitalidade, além do registro fotográfico inicial. Dominguez et al. (2024) acrescentaram a análise da face e do sorriso, definindo a forma ideal dos dentes a partir do comprimento, da largura e da borda incisal, com o auxílio de princípios como a proporção áurea.

Silva, I. et al. (2021) explicaram que, após o exame, é feita a moldagem para obter os modelos de estudo e o enceramento diagnóstico, que pode ser montado em articulador semiajustável. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) destacaram que o enceramento deve reproduzir proporção dentária, pontos de contato, arquitetura gengival, bordas incisais, inclinação axial e zênites gengivais, Lanzaretti et al. (2025) recomendaram fotografias intra e extraorais e modelos de estudo como base para o enceramento, e Dominguez et al. (2024) ressaltaram seu papel na comunicação com o paciente. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) reforçaram que, sem o mock-up, o profissional tem dificuldade para visualizar a forma, a posição e a proporção das futuras restaurações. A partir dele é feito o mock-up, que, segundo Cruz et al. (2023), é totalmente reversível e confeccionado diretamente sobre os dentes com resina bisacrílica, um material de base e catalisador em pontas de automistura, ativado quimicamente. Reis et al. (2018) relataram um caso em que o mock-up foi ajustado de acordo com as observações da paciente antes das facetas, e concluíram que essa etapa motivou a paciente e trouxe previsibilidade e segurança. Bento et al. (2021) também usaram fotografias, enceramento e mock-up no planejamento.

Silva, I. et al. (2021) consideraram o planejamento digital, feito a partir de fotografias, fundamental para a precisão do diagnóstico, e Silva, B. et al. (2021) o utilizaram para definir as medidas ideais dos dentes antes de uma cirurgia periodontal e das facetas. Joshi (2025) mostrou que casos mais complexos exigem um planejamento em etapas, com tratamento das cáries, endodontia, clareamento interno e aumento de coroa antes das facetas.

Silva, I. et al. (2021) recomendaram considerar sempre o clareamento antes das facetas, por ser conservador e permitir associação com outros tratamentos. Segundo os autores, ele torna o substrato mais claro, reduz o desgaste e permite uma camada mais fina de resina, com aspecto mais natural, embora seu resultado nem sempre seja previsível. Pereira et al. (2020) fizeram três sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% e aguardaram 21 dias para a estabilização da cor antes de escolher a resina. Rocha et al. (2021) observaram que o clareamento prévio reduziu a necessidade de desgaste, e Reis et al. (2018), Bastos et al. (2018), Dias et al. (2020) e Bento et al. (2021) também clarearam os dentes antes das facetas.

3.7 Técnica de confecção

3.7.1 Preparo e isolamento

Lanzaretti et al. (2025) recomendaram uma profilaxia profissional dois dias antes do procedimento e, no dia do atendimento, a limpeza do dente com escova e pasta de polimento. Alves, Peres e Lima (2022) e Lanzaretti et al. (2025) indicaram o isolamento absoluto com dique de borracha, e Oliveira et al. (2021) optaram por um isolamento absoluto modificado, para permitir o uso da guia palatina. Joshi (2025) protegeu os dentes vizinhos com fita de teflon antes do condicionamento.

Dominguez et al. (2024) afirmaram que o preparo deve ser mínimo ou ausente, com margens precisas para evitar infiltração e com análise prévia da oclusão. Alves, Peres e Lima (2022) descreveram, quando necessário, a redução vestibular e incisal com remoção das restaurações insatisfatórias, e Vookanti et al. (2026) limitaram o desgaste às áreas manchadas, com 0,5 a 0,75 mm no terço médio e 0,2 a 0,5 mm próximo à gengiva. Dias et al. (2020) fizeram apenas um desgaste leve com pontas diamantadas de polimento.

3.7.2 Seleção de cor

Dominguez et al. (2024) citaram como recursos para a seleção de cor as escalas, os guias de cor e as fotografias digitais. Lanzaretti et al. (2025) e Vookanti et al. (2026) utilizaram a técnica do botão, em que pequenas porções de resina são polimerizadas sobre o dente para testar a cor, e Oliveira et al. (2021) aplicaram incrementos nos terços cervical, médio e incisal sem condicionamento ácido. Pereira et al. (2020) associaram a escala Vita à prova de incrementos, sob luz natural.

3.7.3 Guia palatina e estratificação

Oliveira et al. (2021), Pereira et al. (2020) e Lanzaretti et al. (2025) descreveram que, após o condicionamento e o adesivo, a guia de silicone obtida do enceramento é usada para construir a parede palatina, base para o restante da faceta. Cruz et al. (2023) explicaram que as facetas podem ser feitas à mão livre ou com guias de silicone ou acetato, sempre com a resina aplicada de forma incremental, para reproduzir as características do dente e reduzir os efeitos da

contração. Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) usaram matriz transparente e cunha para construir as faces proximais.

Dominguez et al. (2024) definiram a estratificação como a aplicação de camadas de resina com diferentes cores, opacidades e translucidez para imitar o dente natural, diferenciando a técnica de camada única da técnica estratificada, e destacaram a reprodução de detalhes como mamelos, sulcos e a translucidez da borda incisal. Silva, I. et al. (2021) orientaram que a resina de dentina fique no terço cervical e a de esmalte, voltada para o incisal. Lanzaretti et al. (2025) descreveram a sequência após a guia: construção das paredes mesial e distal, estratificação vestibular para completar a anatomia e a cor, refinamento da forma com discos macios de granulação média e marcação das linhas de transição e dos sulcos de desenvolvimento com lápis colorido, antes do acabamento. Pereira et al. (2020) utilizaram incrementos de resina para dentina e para esmalte. Reis et al. (2018) combinaram a IPS Empress Direct na dentina, por sua menor opacidade, com a Filtek Z350 no esmalte, e Rocha et al. (2021) usaram resinas de efeito para reproduzir a opalescência dos dentes jovens.

Em dentes muito escurecidos, Falcão et al. (2023) aplicaram uma mistura de três pigmentos opacificadores, conferiram o valor por fotografias em preto e branco e só então estratificaram com resina translúcida na palatina, dentina opaca e esmalte acromático translúcido, obtendo cor estável após sete meses. Vookanti et al. (2026) observaram que, na fluorose, o próprio preparo removeu boa parte das manchas, dispensando os opacificadores.

3.8 Acabamento e polimento

Dominguez et al. (2024) afirmaram que o acabamento e o polimento influenciam diretamente a estética, a durabilidade e a resistência ao manchamento, pois eliminam irregularidades que favorecem o acúmulo de placa. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) explicaram que, quando mal executadas, essas etapas deixam porosidades, falta de brilho e alterações de cor, e que quanto mais lisa a superfície, menor o risco de manchamento. Cruz et al. (2023) chegaram a incluir o acabamento e o polimento mal feitos entre as falhas mais comuns das facetas, e Soares e Borges (2023) consideraram a excelência nessas etapas essencial para o sucesso do tratamento.

Silva, I. et al. (2021) explicaram que o acabamento remove excessos e refina os contornos, enquanto o polimento dá brilho e reflexão de luz, e que os contatos oclusais devem ser conferidos em máxima intercuspidação, lateralidade e protrusão. Dominguez et al. (2024) relataram que pontas de borracha e discos de lixa removem os excessos, enquanto pastas e escovas dão o brilho final. Alves, Peres e Lima (2022) citaram discos de óxido de alumínio e tiras de lixa, e Silva, I. et al. (2021), discos de alto brilho e escovas de pelo de cabra. Pereira et al. (2020) usaram pontas diamantadas finas, borrachas de silicone, discos Sof-Lex e discos de feltro com pasta diamantada, Oliveira et al. (2021) preferiram fazer o acabamento e o polimento sete dias após o procedimento, com brocas multilaminadas, discos de granulação decrescente, discos de feltro e pasta de polimento, e Lanzaretti et al. (2025) fizeram novas fotografias sete dias depois, após a reidratação dos dentes, para avaliar o resultado final. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) acrescentaram que essas etapas diminuem a rugosidade, evidenciam os detalhes anatômicos e são decisivas para a longevidade do trabalho.

3.9 Facetas diretas e o periodonto

Santos et al. (2022) realizaram uma revisão integrativa sobre o impacto das facetas diretas no periodonto e alertaram que o uso indiscriminado da técnica pode causar danos aos tecidos gengivais. Segundo os autores, a invasão do espaço biológico, que pode ser causada por restaurações mal adaptadas, lesões de cárie, preparos protéticos, perfurações, reabsorções radiculares e fraturas, pode provocar inflamação gengival mesmo com bom controle de placa, sensibilidade, recessão, formação de bolsa e reabsorção da crista óssea. Para evitar esses problemas, recomendaram manter uma distância média de 3 mm entre a crista óssea alveolar e a margem gengival. Cruz et al. (2023) também incluíram a invasão do espaço biológico entre as falhas das facetas, enquanto Brito, Ferreira e Yamashita (2022) lembraram que, quando bem feitas, elas causam mínima agressão periodontal.

Cruz et al. (2021) relataram o caso de um paciente com facetas antigas de cor insatisfatória e sangramento gengival durante a escovação, que precisou remover e refazer as dez facetas, e concluíram que o respeito aos tecidos periodontais é indispensável para evitar retratamentos. Em outros casos, a correção da gengiva faz parte do tratamento. Silva, B. et al. (2021) realizaram gengivoplastia em uma

paciente com grande exposição gengival e restaurações deficientes, após planejamento digital, e, noventa dias depois, o clareamento e as facetas do dente 15 ao 25, com grande impacto na autoestima da paciente. Lima, Amorim e Pereira (2023) associaram a gengivectomia em bisel interno às facetas em uma paciente com sorriso gengival e dentes curtos, explicando que a cirurgia remove o excesso de gengiva e aumenta a coroa clínica, enquanto as facetas devolvem forma, cor, opacidade e translucidez aos dentes. Nos dois trabalhos, os autores concluíram que a integração entre periodontia e dentística é essencial para um resultado harmônico, e Joshi (2025) também usou o aumento de coroa clínica antes das facetas.

3.10 Longevidade, falhas e manutenção

3.10.1 Longevidade

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) citaram trabalhos que estimam a longevidade das facetas diretas entre cerca de 7 e 10 anos, e Santos et al. (2022) também relataram durabilidade em torno de 10 anos. Teixeira et al. (2022) afirmaram que vários estudos comprovaram essa durabilidade por até sete anos, e Irgang et al. (2020), em um estudo que acompanhou facetas por até dez anos, encontraram 77% de sobrevivência.

Galvão et al. (2025) realizaram uma revisão sistemática, registrada no Prospero, nas bases PubMed, Embase e Cochrane, sem restrição de ano ou idioma, e, entre os 50 artigos encontrados, incluíram cinco estudos clínicos que compararam facetas diretas e indiretas de resina em dentes anteriores. Em um dos estudos, as diretas tiveram 98% de sobrevida e as indiretas, 87%; em outro, as indiretas tiveram 75% em dez anos; e um terceiro encontrou 87,5% de sobrevivência das diretas em dois anos e meio. Os autores concluíram que as facetas diretas parecem durar mais que as indiretas de resina, embora as diferenças entre os estudos tenham impedido uma análise quantitativa. Teixeira et al. (2022), por outro lado, concluíram que as facetas indiretas de porcelana têm sobrevida relativamente maior e mais estabilidade de cor, e Dominguez et al. (2024) também observaram que as facetas de resina costumam ter menor durabilidade que as cerâmicas.

3.10.2 Falhas

Galvão et al. (2025) identificaram o descolamento e a fratura como as falhas mais frequentes nas duas técnicas. Cruz et al. (2023) concluíram que a principal causa das falhas é o desempenho do cirurgião-dentista, citando anatomia inadequada, ausência de ponto de contato, acabamento ruim, diferença de cor e invasão do espaço biológico, e explicaram que o preparo incorreto favorece fraturas coesivas e adesivas e que o manchamento marginal resulta de defeitos de selamento. Os mesmos autores lembraram, porém, que forças oclusais, temperatura intraoral, variações de pH, higiene deficiente e hábitos parafuncionais do paciente também levam a descolamentos e fraturas. Teixeira et al. (2022) relataram que estudos anteriores encontraram margens cervicais lisas em apenas 15% das restaurações avaliadas. Cruz et al. (2021) ilustraram esse cenário com o caso de facetas mal executadas que precisaram ser totalmente refeitas.

Dominguez et al. (2024) descreveram o manejo dessas complicações: fraturas e descolamentos causados por trauma, forças oclusais excessivas ou falhas de adesão podem ser resolvidos com reparos localizados, substituição da faceta ou, em fraturas extensas, até tratamento endodôntico; alterações de cor, com polimento, clareamento ou substituição; e problemas oclusais, com ajustes ou placas de proteção. Os autores citaram ainda a sensibilidade pós-operatória, mais comum quando o preparo é invasivo. Dominguez et al. (2024) e Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) destacaram que a facilidade de reparo é uma vantagem da resina em relação à porcelana.

3.10.3 Manutenção

Rocha et al. (2021) explicaram que a falta de higiene favorece a degradação da matriz da resina e a alteração de cor e textura, e por isso orientaram retornos semestrais. Silva, I. et al. (2021) recomendaram orientar o paciente sobre os hábitos alimentares e a higienização, e Lima et al. (2020) também indicaram retornos periódicos. Dominguez et al. (2024) afirmaram que a higiene e as visitas regulares ao dentista são essenciais para a longevidade das facetas. Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) mostraram que bebidas ácidas degradam a superfície das resinas, e Teixeira et al. (2022) destacaram o uso da placa miorrelaxante em pacientes com bruxismo. Brito, Ferreira e Yamashita (2022) concluíram que a

durabilidade das facetas depende do material, da qualidade da execução e de fatores ligados ao próprio paciente.

REFERÊNCIAS

ALVES, D. L.; PERES, S. S. C.; LIMA, C. M. Faceta direta em resina composta: indicação e técnica. **Revista Cathedral**, v. 4, n. 1, p. 109-116, 2022.

BASTOS, N. A. et al. Clinical performance of the composite resin veneers: the minimally invasive approach. **Archives of Health Investigation**, v. 7, n. 9, p. 392-396, 2018. DOI: 10.21270/archi.v7i9.3151.

BENTO, M. J. et al. Impacto psicossocial na reabilitação estética anterior com resina composta direta: relato de caso. **Archives of Health Investigation**, v. 10, n. 2, p. 209-214, 2021. DOI: 10.21270/archi.v10i2.5083.

BRITO, J. A. O.; FERREIRA, V. S.; YAMASHITA, R. K. Indicações e longevidade das facetas de resina composta: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e467111335738, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35738.

CRUZ, A. I. et al. Troca de facetas em resina composta insatisfatórias, buscando adequação anatômica e estética: relato de caso. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e169101421740, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21740.

CRUZ, K. F. et al. As principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores: revisão de literatura. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 3, p. 75-86, 2023.

DIAS, P. et al. Aesthetic restoration using composite resin in teeth with inactive carious lesions: a conservative and predictable approach. **RGO: Revista Gaúcha de Odontologia**, v. 68, e20200052, 2020. DOI: 10.1590/1981-86372020000522018010l.

DOMINGUEZ, G. P. et al. Facetas diretas em resina composta: uma revisão abrangente. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 7, e12213746470, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i7.46470.

FALCÃO, A. et al. Faceta direta de resina composta utilizando pigmentos opacificadores para reabilitação estética anterior de dente escurecido: relato de caso. **Revista Naval de Odontologia**, v. 50, n. 1, p. 15-20, 2023.

FERNANDES, L. K. P. et al. O método de fotopolimerização é capaz de influenciar nos valores de microdureza das resinas compostas? Um estudo in vitro. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 51, e20220043, 2022. DOI: 10.1590/1807-2577.04322.

GALVÃO, B. W. L. et al. Longevidade clínica das facetas diretas e indiretas em resina composta em dentes anteriores: uma revisão sistemática. **RSBO**, v. 22, n. 2, p. 308-321, 2025.

IRGANG, L. et al. A clinical evaluation of direct veneers made with two types of composites. **Journal of Research in Dentistry**, v. 8, n. 1, p. 10-16, 2020. DOI: 10.19177/jrd.v8e1202010-16.

JOSHI, S. Aesthetic smile makeover with direct resin composite veneers: a case report. **Scientiarum: A Multidisciplinary Journal**, v. 1, n. 5, p. 1-5, 2025. DOI: 10.54646/SAPARS.2025.22.

KORKUT, B.; YANIKOĞLU, F.; GÜNDAY, M. Direct composite laminate veneers: three case reports. **Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects**, v. 7, n. 2, p. 105-111, 2013. DOI: 10.5681/joddd.2013.019.

LANZARETTI, G. et al. Esthetic smile rehabilitation with direct composite veneers: a narrative review with a practical explanation of the technique. **Minerva Dental and Oral Science**, v. 74, n. 4, p. 266-272, 2025. DOI: 10.23736/S2724-6329.25.05161-7.

LIMA, A. P. M.; AMORIM, J. C.; PEREIRA, T. S. Reabilitação estética anterior com gengivectomia e facetas em resina composta. **Scientia Generalis**, v. 4, n. 2, p. 93-103, 2023. DOI: 10.22289/sg.V4N2A7.

LIMA, H. E. R. et al. Fechamento de diastema utilizando resina composta. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 12, p. 95036-95045, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n12-115.

NALBANDIAN, S.; MILLAR, B. J. The effect of veneers on cosmetic improvement. **British Dental Journal**, v. 207, E3, 2009. DOI: 10.1038/sj.bdj.2009.609.

OLIVEIRA, L. M. O. et al. Fechamento de diastema pela técnica direta em resina composta: relato de caso clínico. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, e431101624060, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i16.24060.

PEREIRA, M. R. et al. Reabilitação estética com resina composta em paciente jovem: relato de caso clínico. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 29, n. 88, p. 24-28, 2020.

REIS, G. R. et al. Mock-up: previsibilidade e facilitador das restaurações estéticas em resina composta. **Revista Odontológica do Brasil Central**, v. 27, n. 81, p. 105-111, 2018.

ROCHA, A. O. et al. Intervenção estética anterior por meio de facetas diretas em resina composta: relato de caso. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 3, e6439, 2021. DOI: 10.25248/REAS.e6439.2021.

SANTOS, R. G. et al. O impacto das facetas diretas em resina composta sobre o tecido periodontal: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 7, e54511730235, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30235.

SILVA, B. J. et al. Transformação de sorriso envolvendo cirurgia plástica periodontal e facetas em resina composta: relato de caso. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 1, n. 1, p. 75-86, 2021.

SILVA, I. B. et al. Facetas diretas em resina composta: uma abordagem conservadora (revisão da literatura). **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 11, p. 109291-109307, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n11-518.

SOARES, I. S.; BORGES, T. S. Técnicas e indicações para a realização das facetas em resina composta direta: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, e3312641962, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.41962.

TEIXEIRA, B. C. et al. Longevidade de tratamento reabilitador com facetas diretas e indiretas em dentes anteriores: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, e409111537369, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37369.

TOZO-BURGOS, J. G.; ESCALANTE-OTÁROLA, W.; SÁNCHEZ-TITO, M. Erosive resistance of high-translucency resin composites: new insights for esthetic dentistry. **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 17, n. 12, p. e1508-e1516, 2025. DOI: 10.4317/jced.63433.

VAZ, M. M.; LOPES, G. F.; TOLEDO NETA, M. E. Tratamento reabilitador estético como uma possibilidade para pequenas correções de alinhamento. **Revista Odontológica Integrativa do Centro-Oeste**, v. 2, n. 1, p. 28-42, 2022.

VOOKANTI, V. R. R. et al. Aesthetic transformation of fluorosed teeth using minimally invasive direct composite veneers: a case report. **University Journal of Dental Sciences**, v. 12, n. 1, p. 91-96, 2026. DOI: 10.21276/ujds.2026.12.1.17.